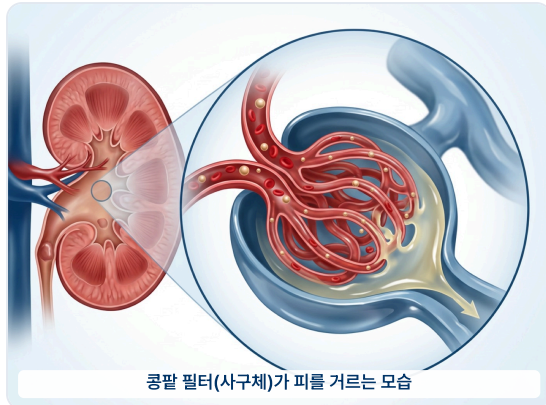


신장기능 eGFR·단백뇨 결과 안내

eGFR은 혈액검사로 추정된 콩팥 여과 능력, 단백뇨·알부민뇨는 소변으로 단백질이 새는 정도를 봅니다. 한 번의 이상만으로 만성콩팥병을 확정하지 않고, 반복 확인과 위험도 평가가 필요합니다.

☞ 수치가 뜻하는 것



수치	뜻 (KDIGO 2024 기준)
eGFR 90 이상	정상(KDIGO 1단계)
eGFR 60~89	약간 감소(KDIGO 2단계) — 단백뇨·혈뇨 등 다른 콩팥 이상이 없으면 만성콩팥병이 아니며, 다른 이상이 함께 있으면 추적
eGFR 60 미만	3개월 이상 계속되면 만성콩팥병
uACR 30 이상	소변 알부민 30 mg/g 이상이면 추적

국가건강검진 결과지는 60 이상을 '정상'으로 판정합니다 — 60~89도 검진 판정은 정상이지만 다른 이상이 있으면 추적합니다.

🔍 왜 재검이 필요한가요?

☞ 일시적으로 나빠질 수 있는 경우	📋 다음 확인 검사
탈수·금식 — 크레아티닌 상승, 소변 농축	크레아티닌/eGFR 재검 — 대개 1~3개월 간격
격한 운동 — 일시적 혈뇨·단백뇨 가능	소변 알부민·크레아티닌 비(uACR) — 거품 여부가 아니라 소변검사로 단백(알부민)이 새는 양을 정확히 잽니다. 30 mg/g 이상이면 추적
감기·발열·요로감염 — 소변 이상 동반 가능	혈압·당뇨 평가 — 콩팥 손상의 가장 흔한 원인
진통소염제 — 소염진통제 복용 시 신장 부담 증가	소변 침사·초음파 — 혈뇨, 결석, 구조 이상 확인
크레아틴 보충제 — 크레아티닌이 올라 eGFR이 가짜 저하로 나올 수 있음	소변검사 준비 — 소변이 진하면 단백뇨처럼 보일 수 있어(가짜 단백뇨), 소변검사만 있는 날은 평소처럼 물을 드세요

🍷 콩팥을 지키는 생활 원칙

줄일 것

- 짠 음식 — 국물·젓갈·가공식품 줄이기
- 진통소염제 남용 — 이부프로펜·나프록센 등 상담 후
- 고단백 보충제 — eGFR 저하 시 무리한 섭취 피하기
- 흡연 — 혈관·콩팥 기능 악화와 연관

📌 관리할 것

- 혈압 목표 확인 — 가정혈압 기록이 도움
- 혈당 관리 — 당뇨가 있으면 당화혈색소와 uACR 추적
- 수분 균형 — 탈수 피하되 심부전·부종은 별도 상담
- 정기 추적 — eGFR 변화 속도와 단백뇨가 핵심
- 칼륨 공포 — 신장수치가 조금 낮다고 과일·채소를 무조건 끊을 필요는 없음, 혈중 칼륨 수치로 판단

⚠️ 빨리 진료가 필요한 신호

소변량이 갑자기 줄거나, 전신 부종이 생기거나, 육안적 혈뇨·옆구리 통증·고열이 있으면 빨리 진료를 보세요. 소변이 거의 나오지 않거나 숨이 차면 응급실로 가세요. eGFR이 30 미만, 단백뇨가 심함, 혈뇨와 단백뇨가 함께 지속되는 경우에는 전문 진료가 필요할 수 있습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — KDIGO 2024 CKD Guideline · KDIGO Potassium Controversies Conference(2020) · National Kidney Foundation

eGFR/ACR 안내 · 국민건강보험공단 일반건강검진 판정기준

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 추적 간격과 약물 조정은 원인, 혈압·당뇨, 이전 수치 변화에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/egfr-proteinuria/

